ICS 11 .020

C 05

广东省针灸学会团体标准

【T/GDZJ XXXX-202X】

岭南特色针灸技术操作规范：司徒氏针挑技术

Standardized manipulations of Lingnan characteristic acupuncture and moxibustion: Needle-Pricking

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布　　XXXX-XX-XX 实施

广东省针灸学会

前言

《岭南特色针灸技术操作规范》共包含以下 5 个部分：

——精灸技术

——岭南传统天灸技术

——灵龟灸法技术

——司徒氏针挑技术

——岭南火针技术

本部分为第 4 部分【**T/GDZJ XXXX-202X**】

本部分按照 GB/T 1.1-2020、GB/T 1.2-2020 与 GB/T 33416-2016 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由广东省针灸学会提出

本部分由广东省针灸学会归口

本部分起草单位：广东省中医院、深圳市宝安区中医院、海南省中医院、佛山市中医院

本部分主要起草人：符文彬

本部分参加起草人：王聪、王舢泽、周鹏、阎路达、梁雪松、张光彩、吴林、冯琦钒、李子勇、李树成、刘志良

引言

岭南针灸名家司徒铃教授在基于“锋针疗法”“半刺法”“刺络法”等古代针法，吸纳民间针挑疗法经验，系统总结了针挑疗法的理论和适应症。司徒铃教授入室弟子符文彬教授进一步细化针挑技术操作、改良针挑工具、拓宽临床适应症，对针挑疗法的完善和发展做出重要贡献。现司徒氏针挑已成为岭南地区广泛应用且独具特色的针刺技术之一，故制定本技术操作的标准性文件，以利于岭南特色针灸技术的规范，以及针灸同仁的学习与运用。

本标准的发布机构提请注意，声明符合本标准时，可能涉及到与挑治针相关的专利的使用。

本标准的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。该专利持有人已向本标准的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本标准的发布机构备案。

相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：符文彬

地址：广州越秀区大德路 111 号

请注意除上述专利外，本标准的某些内容仍可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

1 范围

本部分规定了司徒氏针挑的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本部分适用于司徒氏针挑技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21709.4-2008 针灸技术操作规范第 4 部分：三棱针

GBT 21709.20 针灸技术操作规范第 20 部分：毫针基本刺法

GB/T 12346 腧穴名称与定位

GB 15982 医院消毒卫生标准

3 术语和定义

3.1 司徒氏针挑

使用特制挑治针，于人体特定部位或穴位处，挑断皮下白色纤维样组织，或伴有少许血液放出，以达到防治疾病的一种针刺方法。

3.2 挑治针

针体坚硬，针尖弯折呈钩状，可用于挑拨皮下纤维样组织的针具。司徒氏针挑所用的挑治针主要包括一次性挑治针（专利号：CN202015209U）和钩状挑治针（专利号：CN202104951U）。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 针具、消毒及麻醉准备

准备好一次性挑治针或用高压消毒法消毒的钩状挑治针。

根据需要准备好 0.5%盐酸利多卡因注射液、注射器等麻醉工具。

准备好 75％乙醇或碘伏等消毒工具，以及棉签、敷料、医用胶布等辅助工具。

4.1.2 穴位选择及定位

根据病症选取适当的穴位或治疗部位，常用背俞穴、华佗夹脊、阿是穴等。穴位的定位应符合 GB/T 12346 的规定。

4.1.3 体位选择

根据治疗选穴，选择患者舒适、医者便于治疗的体位。常选用俯卧位或俯伏坐位等。

4.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生，避免污染。

4.1.5 消毒

应对针具器械、施术部位消毒和医者双手进行严格消毒，具体方法应符合 GB/T 21709.4-2008 与 GB 15928 的部分规定。

4.2 施术方法

4.2.1 挑治点选择

根据病症选取适当的穴位或治疗部位，常取背俞穴、华佗夹脊穴与阿是穴。穴位的定位应符合 GB/T12346 的规定。

4.2.2 局部麻醉

根据需要可在施治部位消毒后进行局部麻醉。局部麻醉方法参加附录。

4.2.3 挑治操作

用挑治针针尖对准施治部位中心或麻醉皮丘最高点，挑破皮肤 2～3mm。

将针尖探入创口处的皮下，挑起少许皮下白色纤维样物质，做左右挑拨或旋转牵拉动作。

重复挑治动作，直至将施术部位皮下白色纤维组织挑断。一般挑治动作需要做 10-15 次。

4.3 施术后处理

施术后以无菌纱布覆盖施术部位，并用胶布固定。

施术后处理还应符合 GB/T 21709.4-2008 的相关规定。

5 注意事项

5.1 施术前应告知患者该技术的治疗目的及简单操作过程。

5.2 挑治时针尖应局限在创口内，不要在挑动过程中扩大创面，防止伤口愈合难或留有瘢痕。

5.3 注意预防和处理晕针。具体应参照 GBT 21709.20-2009 中附录 F 中的处理方法处理。

5.4 挑治后若创口处有白色纤维断端露出皮肤外，应将其剪断或埋于皮下后再覆盖纱布；

5.5 挑治后注意保护创口，防止感染。

5.6 嘱患者治疗期间食少辛辣等刺激性食物。

6 禁忌

6.1 血管瘤部位、不明原因的肿块部位不可使用针挑疗法。

6.2 严重心脏病、血液病、糖尿病血糖控制不佳或有严重并发症、肺结核、高血压危象的病人不宜使用挑针疗法。

6.3 孕妇、瘢痕体质人群、精神病患者或精神过度紧张无法配合者不宜使用针挑疗法。

附录

附录 A

（资料性附录）

针挑常用的局部麻醉方法

常用药物：0.5%利多卡因

方法：在施治部位皮下注射约 0.1ml 药物，形成一个皮丘。

附录 B

（资料性附录）

针挑的适应症与疗程

根据文献与临床调研，列举如下适应症：

（1）痛症：偏头痛、三叉神经痛、枕神经痛、颈椎病、肩周炎、肋间神经痛、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、类风湿性关节炎、膝骨关节炎、肌筋膜综合征、带状疱疹后遗神经痛等；

（2）肺系病症：慢性咽喉炎、支气管哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎、过敏性湿疹、荨麻疹、顽固性色素沉着、特应性皮炎等；

（3）心脑病症：中风后遗偏瘫或感觉障碍、癫痫、抑郁障碍、双向情感障碍、面肌痉挛、肌张力障碍、外伤性截瘫；

（4）妇科肾膀胱病症：不孕症、慢性盆腔炎、子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征、慢性前列腺炎、前列腺肥大、不育症等；

（5）其它：甲状腺肿大、痔疮、顽固性呃逆、慢性结肠炎等。

一般每次选穴 4 ~ 10 个，根据病情、选穴，整体和病位局部，针挑治疗频率为一周 1 ～ 2 次，疗程按病种病情决定。

附录 C

（资料性附录）

司徒氏钩状挑治针